

Convulsión febril prolongada

1. Introducción y relevancia clínica

Las **convulsiones febriles (CF)** son el **trastorno convulsivo más frecuente en la infancia**, afectando al 2–5 % de los niños entre los 6 meses y los 5 años.

Corresponden a **episodios convulsivos asociados a fiebre**, sin evidencia de infección del sistema nervioso central ni causa metabólica.

Aunque la mayoría son benignas, un pequeño porcentaje puede presentarse como **convulsiones febriles prolongadas (CFP)** o **complejas**, que requieren **manejo urgente y vigilancia hospitalaria**.

Su importancia clínica radica en:

- Ser causa común de **consultas en urgencia pediátrica**.
 - Ser **pregunta clásica en EUNACOM**, por su definición, manejo agudo y pronóstico.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Durante la infancia temprana, el cerebro presenta una **mayor excitabilidad neuronal** y **menor umbral convulsivo**, especialmente en presencia de fiebre.

La **temperatura elevada (>38 °C)** puede alterar la función de canales iónicos neuronales, desencadenando descargas eléctricas anormales.

Factores predisponentes:

- Infecciones virales respiratorias o gastrointestinales.
- Fiebre rápida o elevada.
- Antecedentes familiares de convulsión febril.
- Inmadurez del sistema nervioso central.

Las convulsiones febriles **no implican daño cerebral** ni epilepsia, pero las formas prolongadas pueden aumentar el riesgo de desarrollar **epilepsia temporal** a futuro.

3. Clasificación

Tipo	Características	Duración	Focalidad	Recurrencia	Riesgo posterior
Simple	Generalizada, tónico-clónica, recuperación completa	<15 min	No	No en 24 h	Bajo
Compleja / prolongada	Focal o prolongada, repetida	>15–30 min	Sí	Sí en 24 h	Mayor riesgo de epilepsia

☐ En EUNACOM: “Convulsión febril prolongada = duración >15 minutos, o varias en 24 h, o con focalidad.”

4. Clínica (signos y diagnóstico diferencial)

A.

Convulsión febril simple

- Edad 6 meses – 5 años.
- Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (sin infección del SNC).
- Convulsión tónico-clónica generalizada <15 min.
- Sin déficit neurológico postictal.

B.

Convulsión febril prolongada o compleja

- Duración >15–30 min.
- Focalidad motora o postictal.

- Recurrencia en 24 h.
 - Puede progresar a **estatus epiléptico febril** si dura >30 min.
-

C.

Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Epilepsia	Convulsiones sin fiebre o con foco EEG persistente
Meningitis / encefalitis	Fiebre + signos meníngeos o alteración prolongada de conciencia
Crisis metabólicas (hipoglucemia, hiponatremia)	Historia compatible o laboratorio alterado
Convulsión febril simple	Duración corta, recuperación rápida

5. Evaluación inicial en urgencias

El objetivo inmediato es **asegurar ABC (vía aérea, ventilación, circulación)** y determinar si se trata de **una convulsión febril simple o prolongada**.

a.

Evaluación clínica

- Temperatura, edad, antecedentes de convulsión, duración del episodio.
- Signos de meningismo o focalidad neurológica.

- Estado postictal (alerta, somnoliento, Glasgow).

b.

Exámenes complementarios (según contexto)

Examen	Indicación
Glicemia capilar	En toda crisis prolongada
Sodio / Calcio / Magnesio	Si persiste alteración de conciencia
PL (punción lumbar)	<12 meses, signos meníngeos o duda diagnóstica
EEG o TAC	Crisis focal o déficit persistente postictal
Hemograma / PCR	Si sospecha infección bacteriana
☐ En menores de 1 año, la meningitis puede presentarse sin rigidez de nuca → realizar PL si duda diagnóstica.	

6. Manejo agudo de la convulsión febril prolongada

a.

Si el paciente está convulsionando:

1 ☐ Estabilización inmediata

- Asegurar vía aérea, posición lateral de seguridad.
- Administrar oxígeno y monitorear saturación.

- Canalizar vía venosa.

2 ☐ Control de la crisis

- **Benzodiacepinas:**
 - **Diazepam IV 0,2–0,3 mg/kg** (máx. 10 mg).
 - Alternativas:
 - **Lorazepam IV 0,1 mg/kg** (máx. 4 mg).
 - **Midazolam IM / intranasal 0,2 mg/kg** si no hay vía venosa.
- Repetir una vez a los 5 min si persiste crisis.

3 ☐ Si continúa convulsionando (>10–15 min):

→ Administrar **fenitoína 20 mg/kg IV lento** o **levetiracetam 40 mg/kg IV**.

4 ☐ Si persiste >30 min →

estatus epiléptico febril → UCI.

b.

Postcrisis

- Control térmico: antipiréticos (paracetamol 10–15 mg/kg/dosis).
 - Buscar foco infeccioso: ORL, pulmonar, urinario.
 - Observación hospitalaria si:
 - Crisis prolongada o recurrente.
 - Menor de 1 año.
 - Recuperación neurológica lenta.
 - Diagnóstico incierto.
-

7. Tratamiento etiológico y profilaxis

a.

Tratamiento de la causa febril

- Manejo sintomático de la infección subyacente (ej. viral respiratoria).
- Antipiréticos no previenen convulsiones, pero mejoran el confort.

b.

Profilaxis anticonvulsivante

- No se recomienda uso rutinario.
 - Considerar en casos seleccionados (CF complejas recurrentes):
 - Diazepam VO 0,3 mg/kg c/8 h durante el episodio febril.
 - Fenobarbital o valproato solo en epilepsia confirmada.
-

8. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Comentario
Estatus epiléptico febril	Riesgo si crisis >30 min
Recurrencia	30 % en simples, 50 % en complejas
Epilepsia posterior	1–2 % (simples), 5–10 % (complejas)
Trauma o aspiración	Durante la crisis, si manejo inadecuado

Pronóstico general **excelente**, sin secuelas neurológicas en la mayoría de los casos.

9. Prevención y educación a los padres

- Explicar el **carácter benigno y autolimitado** de la mayoría de las convulsiones febriles.
 - Enseñar **manejo en domicilio**:
 - Colocar al niño de lado.
 - No introducir objetos en la boca.
 - Controlar tiempo de crisis.
 - Consultar si dura >5 min o si hay dificultad respiratoria.
 - Mantener al día el esquema de vacunación.
 - Educación reduce ansiedad y evita intervenciones erróneas.
-

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas:

1. Convulsión febril = crisis con fiebre sin infección SNC ni causa metabólica.
2. **Prolongada o compleja**: >15 min, focal o repetida.
3. Manejo inicial: ABC + diazepam 0,3 mg/kg IV.
4. Si persiste → fenitoína 20 mg/kg IV o levetiracetam.
5. PL indicada si <12 meses o sospecha meningitis.
6. Antipiréticos no previenen recurrencia.
7. Pronóstico excelente, bajo riesgo de epilepsia.



Errores frecuentes:

- Retrasar benzodiacepina esperando recuperación espontánea.
 - No medir duración exacta de la crisis.
 - No considerar meningitis en <1 año.
 - Administrar antipiréticos como “profilaxis anticonvulsiva.”
 - No hospitalizar convulsión prolongada.
-

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Convulsión febril prolongada:** >15 min, focal o recurrente en 24 h.
2. Ocurre entre **6 meses y 5 años**, asociada a fiebre sin causa neurológica.
3. **Manejo inicial:** ABC + diazepam 0,3 mg/kg IV (o midazolam intranasal).
4. Si persiste: fenitoína o levetiracetam IV → UCI si >30 min.
5. Buscar foco infeccioso y descartar meningitis en <1 año.
6. No requiere anticonvulsivantes prolongados.
7. Pronóstico favorable, con baja recurrencia de epilepsia.